

# 智能纪要：医保业务问题分析与未来规划 2026 年4月17日

录音主题：医保业务问题分析与未来规划

录音时间：2026年4月17日（周五） 16:21 - 17:02（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

## 总结

医保业务现状、问题与未来优化方向分享

 **核心结论：**

- 当前医保业务面临政策复杂、系统报错信息不友好、患者体验差等多重挑战，需系统性优化。
- 计划通过业务流程线上化、引入AI辅助、优化报错反馈机制等方式提升服务效率与专业性。
- 目标是构建公平、专业、高效的智慧医保服务体系，需跨部门紧密协作。

核心业务现状与挑战

| 业务领域    | 核心变化/特点                | 主要挑战/问题                     |
|---------|------------------------|-----------------------------|
| 门诊慢特病认定 | 糖尿病认定标准升级，需并发症或口服药控制不佳 | 医疗文书记录要求高，需副高以上职称医生出具       |
| 药品支付    | 支付必须满足药品说明书法定适应症       | 超说明书用药（超适应症/剂量/疗程）医保不支付     |
| 双通道特药   | 药品数量增至288种，年增长率超100%   | 认定标准复杂，医疗文书记录要求高，业务流程责任划分不清 |
| 智能审核扣款  | 医保局基于规则库筛选疑点数据扣款       | 医院需自行申诉，申诉材料准备效率低、准确性差      |

现存问题与患者体验痛点

 **结算报错信息不友好**

- 医保接口返回的报错信息由 **各统筹区自行维护**
- 信息表述不一，患者与窗口人员均 **难以理解**
- 常见报错包括未备案、机构限制、待遇异常等
- 导致患者在不同部门间往返， **就医体验差**

 **业务流程与政策复杂性**

- 慢特病报销比例、起付线、封顶线 **因地而异**
- 成都地区门特业务限定在 **同一家医疗机构**
- 异地就医不支持移动支付，患者 **结算不便**
- 患者对自费项目、限定支付条件等 **认知不足**

 **信息系统与协议要求**

- 需按 **国家统一编码标准** 开发并维护接口
- 需将医保监管规则前移至结算前进行提醒
- 医师、护士信息变更需 **及时维护** 至医保系统
- 信息传输需满足 **真实、完整、及时** 的要求

未来规划与探索方向

 **近期优化项目**

- 门特认定线上化，改善患者体验
- 增设自助机刷卡功能，分流窗口压力
- 开发外伤业务线上审批与经办流程

 **AI应用探索**

- 临床端：智能提醒完善医疗文书记录
- 患者端：AI解析报销政策与未报原因
- 业务端：辅助药品说明书用药审核

 **服务理念目标**

- 追求公平、专业、高效的医保服务
- 减少患者医保结算等待时间
- 加强信息部门与医保办的密切合作

内容由 AI 生成

音频围绕医保业务展开，涵盖认定标准、支付规则、业务流程、报错处理等方面，探讨了当前存在的问题及改进方向，旨在提升医保服务质量和患者就医体验，内容如下：

医保认定与支付规则

- 认定资料要求
  - 认定需有依据：医保认定需在相应报告或文书做好记录，否则可能被定性为骗保并面临处罚。

| 认定阶段 | 核心条件                                                                        | 医疗文书要求      | 医生资质要求  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 旧标准  | 血糖报告达标+病情证明                                                                 | 无特殊要求       | 未提及     |
| 新标准  | <ul style="list-style-type: none"><li>并发症存在</li><li>或口服药控制不佳需长期治疗</li></ul> | 需记录并发症/用药情况 | 副高级以上职称 |

新标准更强调临床治疗需求和医疗文书规范性，对医生资质提出明确要求。

AI 生成

糖尿病医保认定标准新旧对比

- 糖尿病认定升级：糖尿病认定标准升级，需满足存在并发症或口服用药控制不住需长期降糖治疗等条件，且需医疗文书有依据，医生职称要求副高级以上。

◦ 药品支付规定

- 符合说明书：药品支付需满足药品说明书，医保基金支付必须符合法定适应症，超说明书用药（包括超剂量、改变用药途径、超疗程等）医保基金不予支付。
- 留存用药依据：开展医保服务和自费服务需患者同意，协议报销需满足政策并留存用药依据，如医疗文书或检验检查报告。

◦ 诊断标准差异

- 临床与医保诊断：医院存在临床诊断和医保诊断，临床诊断用于治疗，满足病历书写规范即可；医保诊断为简化的 ICD - 10，用于统计分析和医保支付。
- 药品报销条件：以托莱西单抗为例，报销需满足说明书和医保支付限定条件，医疗文书需记录药物治疗病史和诊断信息，符合医保 ICD - 10 诊断才能通过智能审核。

● 慢特病业务情况

◦ 全省标准与报销差异

- 标准与范围一致：全省门诊慢特病标准和病种范围一致，但报销比例、门槛费、封顶线等在不同统筹区存在差异。
- 认定与结算范围：首次认定为成都市和省本级，联网结算包括省内异地和跨省异地，结算涉及定点机构信息管理。

◦ 报销影响因素

- 目录与诊断问题：患者报销受目录外用药、诊断不符合医保诊断库、病种用药分类错误等因素影响。
- 异地政策问题：患者对异地政策不了解，如起付线、封顶线等，影响报销。
- 结算方式问题：患者希望实现医保移动支付，但省内异地和外省异地受省医保局业务推广限制暂无法支持。



AI生成

慢特病报销影响因素分析

● 医保特药业务

◦ 业务增长情况

- 药品数量增加：双通道供药药品数量不断增加，2026 年最新有 288 个双通道药品。

- 业务增长率高：2025 年门特业务结算人次相比 2024 年增长 30%，双通道药品连续几年保持 100%以上增长率。

- **业务特点与挑战**

- 认定标准严格：医保为每个特药制定认定标准和所需证明材料，如基因报告，但患者常不明白所需材料。
- 系统开发改进：开发特药系统将业务迁移到线上，患者按医生勾选标准提交材料，审核通过后可在院内或院外结算。
- 管理要求较高：全省统一经办，认定医生权限有管理，医疗文书记录要求高，业务流程复杂，责任划分存在争议。

- **医保智能审核与扣款**

- **审核方式与数据筛选**

- 借助知识库筛选：医保智能审核针对医院传给医保的清算数据，借助审核知识库、规则库筛选，区分疑点数据和合规数据。
- 不同申诉模式：多数医院将扣款申诉交给临床医生，而本医院由医保办进行全院扣款数据申诉。

- **申诉流程优化**

- 规则调整：根据政策改变调整审核规则，对新出现的扣款情况进行审核限制。
- 自动生成申诉材料：借助审核记录和接口收集数据，自动生成申诉语句和佐证材料，提高申诉效率和通过率。

- **医保业务信息问题及改进方向**

- **报错信息问题**

- 解释不清晰：医保结算报错语句由各主区维护，解释不详细，患者和窗口人员看不懂，影响业务经办体验。
- 常见报错情况：包括未备案、异地支付报错、门特机构变更、特药处方开具失败、结算期报错、门诊认定信息缺失、医保待遇问题等。

- **改进措施探讨**

- 信息整理与优化：探索对报错信息进行整理和梳理，以通俗易懂的方式呈现并提供后续指引。
- 明确解决途径：确定报错后的解决途径，如截图发送给指定人员，由医院协助解决。

- **未来探索方向**

- **业务线上化**

- 门特认定线上开展：将门特认定放在线上，类似特药业务方式，改善患者体验。
- 自助机功能优化：在门侧或就诊处设置自助机，满足患者刷卡需求。

- 外伤业务线上办理：开发外伤业务流程，将资料审批和业务经办通过线上办理。

- **AI 应用探索**

- 临床端辅助：借助 AI 提醒医生完成医疗文书记录，辅助说明书用药审核。
- 患者端服务：利用 AI 解析患者报销问题，主动推送医保服务，提升患者就医体验。

- **后续工作计划**

- **整合报错提示**：与医保办合作，整合医保报错提示，以通俗易懂的方式呈现并提供后续指引。
- **推进业务线上化**：将门特认定、外伤业务办理等向线上转移，提高业务办理效率。
- **探索 AI 应用**：尝试将 AI 应用于医保服务的临床端、患者端和经办端，提升服务质量和精准度。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 智能章节

### 00:00 医疗认定资料要求及糖尿病认定政策更新

本章节强调认定需在报告或文书做好记录，无资料认定可能被定性骗保并处罚医院。糖尿病认定标准升级，新门诊办理要求满足存在并发症或口服用药控制不住需长期降糖治疗等情况之一，长期用胰岛素控制要有医疗文书依据，且提供依据的医生需副高级以上职称。

### 01:14 医保药品支付、慢特病及特药业务情况与挑战

本章节围绕医保业务展开，包括药品支付需满足说明书，超说明书用药医保基金不支付；慢特病全省标准和病种范围一致，但报销比例等有差异，结算存在问题；医保特药数量增加、增长率高，开发特药系统迁移业务至线上，不过该业务存在管理、文书记录、流程责任划分等问题。

### 12:30 医保智能审核扣款申诉模式改进成效显著

本章节介绍了医保智能审核业务，即针对医院传给医保的清算数据，借助审核知识库、规则库筛选，区分疑点和合规数据。不同医院扣款申诉管理模式不同，该医院由医保办负责全院扣款申诉。会围绕政策调整审核规则，还进行规则上线测试。借助审核记录节点、收集数据，自动生成申诉语句和佐证材料，提高了申诉效率和通过率。

### 16:06 医保业务结算报错问题及解决方向探讨

本章节汇报医保业务过程中的信息现象与情况。患者结算时常遇报错问题，如未备案、异地支付报错等，报错语句解释不明影响体验。还提及门特机构变更复杂、医生端特药处方开具失败、结算期报错、门诊认定信息缺失、医保局系统问题、处方交叉报错及医保待遇问题等，部分问题需联系运维或反馈医保局处理。

### 24:24 门诊慢特病信息及医保业务接口、编码管理要求

本章节主要介绍了门诊慢特病未认定信息及医保信息系统相关内容。乙方需按医保政策规范对接更新接口，积极推广电子凭证使用，自行选运营商并承担费用。编码按国家统一标准开发维护，医保、医

师等信息变更要及时维护。医保业务管理中相关人员纳入支付资格管理，工号需自行保管。

### 25:53 医保监管试点医院协议对信息的要求

本章节主要讲述了国家医保监管系统前移，医院作为国家医保监管试点医院，需将医保监管规则前移至结算前完成。协议要求医院主动接入医保监管系统，实现监管提醒和统计功能，同时在信息传输上要做到真实、完整、及时，这是协议对医保信息的主要要求。

### 26:48 医保业务线上门特认定及自助机刷医保卡计划

本章节说话人1汇报医保业务近期与信息中心推进及未来探索实践之事。一是计划将门特认定放在线上，以类似特药方式开展，改善患者体验、满足需求；二是很多病人就诊前习惯刷医保卡，虽经告知仍会排队刷，为此准备在门侧或就诊处设置自助机，让有需求的病人自行刷卡。

### 27:47 外伤业务与住院财务合并及线上办理规划

本章节主要提及外伤业务相关情况。医助一楼5号窗口，即以前办住院审核的业务窗口已关闭，外伤业务与住院财务合并。目前通过微信群线下模式办理，未来计划开发相应外伤流程，将外伤资料审批及业务经办通过线上办理，这是近期规定要做的事。

### 28:23 医保智慧大赛探索AI在医保服务的应用

本章节主要提及国家医保每年举办医保智慧大赛，探索将AI引入医保服务，包括临床端、患者端和经办端。临床端可借助AI提醒资料记录、辅助说明书用药审核；患者端可利用AI解析报销信息、进行业务引导，主动推送医保服务，保障患者疾病治疗连续性并减轻就医负担。

### 30:49 医院医保服务方向、要求及部门合作展望

本章节主要探讨了未来医保探索方向。从患者角度希望医保报销多、水平高，而有质量的医保需公平、专业、高效。公平指不因支付背景等影响报销；专业要求梳理规则和数据；高效则要减少患者医保审核、结算及等待时间。强调信息数据管理部的支持，期望两部门继续合作提升医院医保服务经办与管理。

### 33:03 医保报错提示优化及处理流程改进探讨

本章节主要讨论医保报错界面问题。说话人3提出医保接口返回信息让患者和工作人员都难理解，建议整合信息以大白话呈现并给出指引。说话人2认同要提升体验，提出考虑报错后的解决途径，根据报错比例采取不同打法，还设想简化报错提示流程，方便老百姓。

### 39:44 医保数据复杂性、专户建设及价值探讨

本章节主要围绕医保相关话题展开讨论。说话人4指出医保数据复杂，提取维度广，医保专户正在建设中。说话人2询问医保专户负责人，还提及数据处未建好医保单，并询问是否值得建设。说话人4认为值得，因目前很多医保数据从原始数据获取，之后部门工作人员将讲解DRG和结算清单。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 关键决策

- **关键决策：**优化医保结算报错提示，提升患者就医体验。
    - **问题：**医保结算报错提示信息不统一、不清晰，患者和工作人员难以理解，影响患者就医体验。
    - **讨论方案：**
      - 说话人3提出整合医保结算报错提示，借用信息化手段，以大白话口语式呈现，并加上后续指引。
      - 说话人2提出设计报错处理流程，报错后告知患者截屏发给指定人员，等待电话解释或排查指导。
    - **决策依据：**当前报错提示影响患者就医体验，需要进行优化，且要考虑不同报错情况的处理方式和成本。
- 

- **其他决策：**
  - a. 探索将门特认定放在线上开展，类似于特药的方式。
  - b. 在门侧或就诊处放置自助机，方便患者刷卡。
  - c. 开发外伤业务线上办理流程，将外伤资料审批和业务经办通过线上进行。
  - d. 考虑将AI应用于医保服务，包括临床端、患者端和经办端。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 金句时刻

「站在患者的角度，希望医保报得越多越好，水平越来越高；但站在医保的角度，有质量的医保一定是公平、专业、效率的。」

—— 准确概括了患者和医保方对于医保的不同期望，引发对医保服务质量的思考。

「将医保结算报错提示整合，以大白话口语式呈现，并加上后续指引，有助于提升患者就医体验，也为工作人员提供指引。」

—— 提出了改善医保结算报错提示的具体方案，具有实际操作意义。

「今后的错误提示只有一个提示，支付失败后点开详情，告知患者截屏发给谁，让老百姓方便一点，等待电话解释或排查指导。」

—— 设计了简洁明了的报错处理流程，突出了以患者为中心的服务理念。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

## 相关链接

- 妙记：[医保业务问题分析与未来规划](#)
- 文字记录
  - [医保业务问题分析与未来规划 2026年4月17日](#)